AUDIT CLINIQUE DES DÉCÈS DES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 59 MOIS SOUFFRANT DE DÉNUTRION AIGUE SÉVÈRE DANS LE DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURÔ SANOU

Nom du présentateur : ILBOUDO Wenbénédo John Davis
Auteurs et coauteurs : IWJD et al.
Affiliations : Département de Pédiatrie CHUSS

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Problème majeur de santé publique : **5 m** de décès, 2021 (UN)
- Population cible : enfant de moins de 5 ans
- Mortalité au BF ↗ : 1,6% (2021) ➡ **1,7%** (Annuaire Stat BF 2022)
- Au CHUSS : mortalité de **6,07%** en 2022
- Peu d'études

Objectif

- Général : mener un audit clinique des décès des enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de dénutrition aigue sévère décédés
- Spécifiques : déterminer la mortalité, les caractéristiques cliniques, les aspects diagnostiques et thérapeutiques et les causes directes des décès des enfants âgés de 6 à 59 mois dénutris aigue sévère

Matériel et méthode(s)

- Cadre et champ d'étude : Pédiatrie du CHUSS
- Type et période d'étude : transversale, descriptive et à collecte rétrospective allant du 1er Janvier 2023 au 30 Juin 2024
- Population et critères d'inclusion : enfants de 6 à 59 mois dénutris aigues sévères et décédés durant la période d'étude

Matériel et méthode(s)

- Echantillonnage : exhaustif
- Taille de l'échantillon : 32
- Outils et techniques de collecte : fiche de collecte individuelle, dossiers cliniques des patients et registres d'hospitalisation

Matériel et méthode(s)

- Variables d'étude : mortalité, caractéristiques sociodémographiques, cliniques, aspects diagnostiques et thérapeutiques et les causes directes des décès
- Saisie et analyse des données : Epi DATA, Microsoft Word et Excel

Résultats

- Mortalité

599 enfants [6-59mois] 38 décès enregistrés : mortalité de **6,34%**

- Caractéristiques sociodémographiques

Age moyen 17,25 mois [6mois,39mois], tranche de 12-23 mois ➡ 50%

Sex-ratio : 0,6

Résidence rurale : 56,25%

Résultats

- Caractéristiques cliniques

Motif d'admission : Fièvre/altération EG **78%**, Troubles digestifs 71%

Type de dénutrition : émaciation sévère n=26 → **81,25%**

Complications : déshydratation **87,5%** fièvre **81,25%**

lésions cutanées 18,75% choc septique 12,5%

Résultats

- Caractéristiques paracliniques

Tableau I : répartition des cas selon les caractéristiques biologiques

Bilans paracliniques	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Hypoglycémie	6	**18,75**
Dépistage Paludisme		
TDR Positif	6	**20**
GE Positive	4	13,33
Anémie modérée	19	**59,38**

Résultats

- Aspects diagnostiques

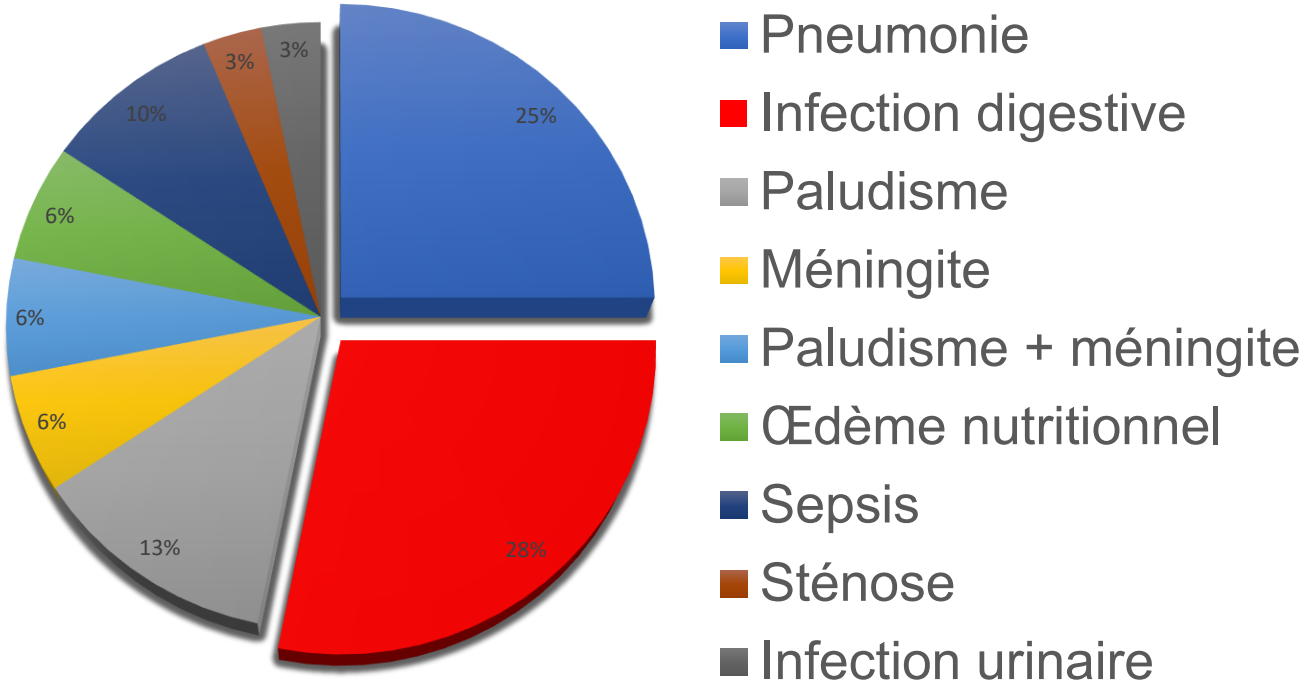

Figure 1 : répartition des cas selon les pathologies diagnostiquées

Résultats

- Aspects thérapeutiques

Traitement reçu avant admission : inadéquat : **12,5%** (n=4)

Traitement en hospitalisation
- Médicale : inadéquat 43,75% (n=14)
- Nutritionnel : inadéquat **83,34%** (n=10)

- Causes directes des décès

Sepsis : **40,6%** (n=13)

Déshydratation : 28,12% (n=9)

Conclusion

Dénutrition aigue sévère + complications

=

Mortalité non négligeable

Ecarts thérapeutiques

=

Mortalité

Maitrise du PCIMA et le bon usage des fiches soins critiques

=

Baisse mortalité

Merci pour votre attention